PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Prévention des RPS dans la fonction publique

14-98 DGAFP - Accord-cadre de 2013 sur la prévention des risques psychosociaux — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'obligation de sécurité de résultats en matière de santé physique et mentale incombe à tous les employeurs publics et privés.
2. L'évaluation des risques psychosociaux doit impérativement prendre en compte la dimension de genre car les femmes sont statistiquement plus exposées.
3. Le CHSCT est l'instance pivot pour le diagnostic et la mise en œuvre de la prévention.

Ambition et principes de prévention

Notion	À retenir
Obligations et santé	L'**obligation de sécurité de résultats** (physique et mentale) incombe aux employeurs. La santé est un **complet bien-être physique, mental et social** (OMS, **1946**).
Principes de prévention	Respect de l'**art. L. 4121-2 du Code du travail**. Éviter les risques, évaluer l'inévitable et combattre **à la source**. Priorité à la **protection collective**.
Objectifs et engagements	Impulsion majeure pour la **prévention des RPS**. Supprimer/réduire les **tensions** et **exigences émotionnelles**. Redonner de l'**autonomie** et favoriser le **dialogue**.

Définition et enjeux des RPS

Notion	À retenir
Dimensions Gollac	Six dimensions : **exigences/intensité du travail**, **exigences émotionnelles**, **manque d'autonomie**, **mauvaise qualité des rapports sociaux**, **conflits de valeur** et **insécurité de la situation de travail**.
Impacts santé/service	Santé : **troubles psychologiques, physiques et sociaux** (**fatigue**, **sommeil**, **maladies psychiques**, **dépression**, **TMS**, **maladies cardiovasculaires**). Service public : **désengagement**, **absentéisme accru** ou **conflits**.
Genre et réorganisations	Femmes plus exposées (**> 1/4**) que les hommes (**1/5**) selon **Sumer 2010**. Nécessité d'une **analyse/ évaluation sexuées** et vigilance lors des **réorganisations**.

Mise en œuvre des plans d'évaluation et de prévention

Notion	À retenir
Diagnostic et DUERP	Diagnostic partagé local selon les **6 dimensions** de **Michel Gollac**, débattu en CHSCT ; intégration obligatoire au **DUERP**, avec les programmes annuels de prévention.
CHSCT et agents	Le **CHSCT** est consulté/réuni (diagnostic, mesures, suivi) ; les **agents** sont des relais indispensables pour le travail réel.
Calendrier et pérennité	Initiation **2014**, achèvement **2015** ; premier bilan et évaluation globale au **1er semestre 2016**.

Dispositifs d'appui et de formation

Notion	À retenir
Appui méthodologique	Outils de l'**Anact**, **HAS**, **FNP de la CNRACL** ou **INRS** (brochures **ED 6139** et **ED 6140** pour le document unique). Guide sur www.fonction-publique.gouv.fr.
Formation initiale/continue	Développement dès **2014**. Module **RPS/QVT** intégré dès **2015** en écoles de service public, paramédicales et sages-femmes. **CHSCT** : **2 journées** dédiées en **2014** ou **2015**.
Culture de prévention	Campagne de sensibilisation (livret **2013**). Page sur www.fonction-publique.gouv.fr renvoyant vers www.travailler-mieux.gouv.fr. Formation pratique obligatoire (**art. 6 décrets n° 82-453 et n° 85-603**).

Rôle et accompagnement de l'encadrement

Notion	À retenir
Responsabilités juridiques	L'employeur assure la **sécurité** et la **santé physique et mentale** (**art. L 4121-1 du Code du travail**). Le chef de service a des obligations en **hygiène**, **sécurité** et **prévention des RPS**.
Moyens d'action	Redonner **autonomie** et **marge de manœuvre** aux agents, notamment aux cadres ; les encadrants en ont besoin pour l'**efficacité** et la **cohésion** de l'équipe. Soutien et espaces de discussion.
Formation et évaluation	Formation **systématique** (initiale et continue). La **qualité de vie au travail** entre dans les objectifs de l'encadrement. L'évaluation des cadres dirigeants intègre l'existence et la qualité du **DUERP**.

Évaluation et suivi du plan national

Notion	À retenir
Indicateurs de réussite	**Diagnostics partagés en CHSCT** d'ici **fin 2014** ; volet RPS dans le **DUERP** ; plans d'action réduisant les risques à la source.
Formation spécialisée du Conseil commun	**Observatoire** des politiques de santé/sécurité ; reçoit les **synthèses** des remontées ; bilan annuel, premier au **1er semestre 2016**.
Commission de suivi des signataires	Comité de suivi avec les **signataires** ; premier bilan d'étape **avant fin 2015**.

Renforcement des acteurs de la prévention

Notion	À retenir
Moyens des CHSCT	Volume du **Code du travail** pour **FPE** et **FPT** (hors **FPH**). Membres : **2 j/an** (0-199 agents) à **12 j/an** (> 10 000) ; secrétaires **2,5** à **15 j/an**. Formation : **5 jours** minimum.
Médecine de prévention	Priorité au **recrutement** (rémunération, internes, stages) et **attractivité** (grille **CISME**).

Pièges et confusions

⚠ Confondre la prévention primaire, qui vise à supprimer les risques à la source, avec les autres formes de prévention.
⚠ Traiter la prévention des RPS de manière isolée au lieu d'une démarche intégrée à la qualité de vie au travail.
⚠ Oublier que l'encadrement peut être à la fois acteur de la prévention et lui-même exposé aux risques.
⚠ Négliger la dimension de genre lors de l'évaluation des risques.

Sigles et définitions

RPS risques pour la santé mentale, physique ou sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels
DUERP document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit intégrer l'analyse des facteurs de risques psychosociaux
CHSCT comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, instance pivot ; remplacé (élections de décembre 2022) par la formation spécialisée du comité social d'administration
DGAFP direction générale de l'administration et de la fonction publique chargée de synthétiser l'information sur la mise en œuvre du plan
ISST inspecteur santé et sécurité au travail, peut être saisi en cas d'absence de réunion du CHSCT sur une période de neuf mois
INRS institut national de recherche et de sécurité, fournit des outils comme les brochures ED 6139 et ED 6140

Auto-test

1. Quelles sont les 6 dimensions de Gollac ?
2. À quel document l'analyse des facteurs de risques psychosociaux doit-elle être intégrée ?
3. Quelles mesures de protection sont prioritaires ?
4. Que doivent faire les employeurs pour assurer la cohésion des équipes via l'encadrement ?
5. Quelle est la définition de la santé selon l'OMS (1946) ?

Réponses : **1.** exigences/intensité du travail, exigences émotionnelles, manque d'autonomie, mauvaise qualité des rapports sociaux, conflits de valeur et insécurité de la situation de travail · **2.** au DUERP · **3.** les mesures de protection collective, sur les mesures individuelles · **4.** redonner plus d'autonomie et de marge de manœuvre aux cadres · **5.** un complet bien-être physique, mental et social

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.